



Consilio

MedicinaInteligente

SEGURIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN

La segunda opinión que siempre está.

Consilio cruza los medicamentos que se indican —y el perfil del paciente— contra fuentes públicas en el momento: interacciones, duplicidades y alertas contra el paciente, con la gravedad más alta que encuentra y diciendo de dónde salió cada aviso.

237.160

pares de fármacos con interacción registrada

6.522

alertas fármaco-patología

1.971

fármacos, 67,6 % con nombre en castellano

76

clases de duplicidad terapéutica

Pruébalo sin instalar nada

Demo pública con ejemplos listos y las cifras de cada fuente a la vista.

consilio.medicinainteligente.ai →

Brochure · cifras al 26/09/2026, tomadas del propio sistema en producción

EN EL MOMENTO JUSTO

Avisa cuando el médico todavía puede cambiar de idea.

Cuando se agrega un medicamento, Consilio dice **en ese instante** si hay algo que conviene saber. No al guardar, no en un reporte al día siguiente. **Y no bloquea:** avisa, muestra la evidencia y el médico decide.

1

Cruza los medicamentos entre sí

Revisa todas las combinaciones entre los medicamentos indicados. Cada hallazgo trae su gravedad, la fuente que lo respalda y, cuando la fuente lo tiene, el mecanismo y qué hacer.

Warfarina + Ibuprofeno

GRAVE

Aumento del riesgo de hemorragias, especialmente gastrointestinales. **Qué hacer:** valorar beneficio/riesgo, añadir gastroprotector y controlar signos de hemorragia.

Fuente: AEMPS, con mecanismo y manejo en castellano

Sildenafil + Nitroglicerina

GRAVE

Digoxina

GRAVE

Tramadol + Fluoxetina

GRAVE

Amiodarona +

Pares clásicos que hoy salen graves gracias a la cobertura DDInter completa (ver página 4)

2

Los cruza contra el paciente que tiene delante

Con lo que se sabe del paciente, Consilio indica si alguno de esos medicamentos no le conviene **a esa persona**:

Embarazo, por semana de gestación

Lactancia

Función renal

Función hepática

Alergias

Patologías por CIE-10

Edad avanzada

5.112 contraindicaciones y 1.410 precauciones, más 166 criterios de prescripción en el adulto mayor, que se muestran como “*verificar si...*” cuando dependen de un dato del paciente que no se cargó.

3

Entiende el diagnóstico como está escrito

Se carga el código CIE-10 de la historia clínica, con su subcódigo. Consilio entiende la jerarquía: un paciente con **N18.5** (enfermedad renal crónica, estadio 5) se evalúa como **N18** y recibe las advertencias de la insuficiencia renal, aunque la base las tenga ancladas al código padre. Hay 552 códigos CIE-10 consultables.

4

Dice lo que no pudo evaluar

Un medicamento sin información aparece como **no evaluable**, nunca como seguro. Y si una consulta falla, el resultado se marca como incompleto. Un vacío tranquiliza, y tranquilizar sin haber evaluado nada es la peor forma de fallar que tiene una herramienta clínica.

NUEVO EN ESTA VERSIÓN

Detecta el mismo tratamiento recetado dos veces.

Paracetamol solo y un antigripal que también lo trae. Dos benzodiacepinas de marcas distintas. Consilio busca la duplicidad en **tres capas**, y cada una declara por qué alertó, o por qué no.

CAPA 1

Misma sustancia

El mismo principio activo en dos productos distintos, aunque uno sea un combinado.

Paracetamol +
paracetamol/codeína

ALERTA

CAPA 2

Misma clase

Clases terapéuticas de la AEMPS con cupo. La clase es el ATC de 4.º nivel de cada fármaco, y los combinados se descartan a propósito.

Diazepam + lorazepam · clase
N05BA

ALERTA

CAPA 3

Excepciones curadas

Las asociaciones que son tratamiento correcto se muestran como **no alertadas**, con su motivo a la vista.

Hidrocortisona +
fludrocortisona

NO ALERTADA Addison

Por qué no alerta todo lo que “se parece”

Una regla ingenua por grupo ATC haría saltar la triple terapia antihipertensiva estándar. Consilio descarta los códigos de combinado, y por eso **no alerta IECA + antagonista del calcio + tiazida, ni ARA II + tiazida**, que son asociaciones de guía y no duplicidades.

Enalapril + Amlodipino + Hidroclorotiazida

Sin duplicidad: tres clases distintas, asociación de guía.

12/12

casos clínicos de referencia
resueltos correctamente

Medido con la batería de evaluación de duplicidad al desplegar (`eval_duplicidad.py`), incluidos los casos que *no* deben alertar.

Clases terapéuticas vigiladas	76
Fármacos asignados a una clase	662
Excepciones curadas	1

Una alerta suprimida **no desaparece**: se muestra como “no alertada”, con el motivo y la referencia. Así el médico ve qué se evaluó, y el equipo clínico puede auditar cada excepción.

VERIFICABLE EN LA DEMO

Cuatro diferencias que se pueden comprobar en cinco minutos.

1 Cada hallazgo dice de dónde salió

Cada alerta declara su fuente, y si la gravedad vino estructurada o se dedujo del texto de un prospecto. El médico puede pesar el aviso en vez de tratarlos a todos igual.

2 Las supresiones se ven, con su motivo

Lo que no se alertó por una excepción clínica aparece como “no alertada” y explica por qué. Nada se descarta en silencio.

3 Lo no evaluable se declara

Un medicamento sin datos se marca como no evaluable, nunca como seguro. Una consulta que falla se marca como incompleta.

4 La gravedad más alta, y quién la dijo

Cuando las fuentes no coinciden en la gravedad de un par, Consilio se queda con la más alta y lo declara. Esconder un desacuerdo entre fuentes no es resolverlo.

NUEVO · COBERTURA COMPLETA

DDInter, las 14 categorías ATC

Se incorporaron las categorías que faltaban, entre ellas **cardiovascular**, **sistema nervioso y antiinfecciosos**. Hoy DDInter aporta **234.981** interacciones, y pares clásicos como sildenafil + nitroglicerina, tramadol + fluoxetina y amiodarona + digoxina salen como **GRAVE**

NUEVO · CASTELLANO DE FUENTE OFICIAL

Habla como escribe el médico

1.333 de 1.971 fármacos (67,6 %) tienen nombre en castellano, tomado de los diccionarios oficiales de la AEMPS y del vademécum uruguayo, sin traducción automática. Se busca en los dos idiomas: *amlodipino* encuentra lo mismo que *amlodipine*.

Los textos que sólo existen en inglés (prospectos de openFDA) se muestran en su idioma original, con un aviso.

QUÉ HAY ADENTRO

Publicamos cuánto cubrimos, y cuándo se actualizó.

Estas cifras no son de un folleto: salen del propio sistema, y la sección **Transparencia** del sitio de demo las muestra en vivo, fuente por fuente.

237.160

pares de fármacos con
interacción registrada
241.235 registros de 3 fuentes



Grave **40.292** Moderada **146.404**
Leve **9.736** Revisar **44.803**

"Revisar": la fuente documenta la interacción pero no le asigna gravedad. Se muestra igual, en violeta, para que no pase desapercibida.

POR FUENTE

INTERACCIONES

DDInter, base clínica estructurada	234.981
Prospectos oficiales de EE. UU. (openFDA)	4.433
AEMPS, con mecanismo y manejo en castellano	1.821

6.522

alertas fármaco-patología
5.112 contraindicaciones · 1.410
precauciones · 552 códigos
CIE-10

166

criterios de prescripción en el
anciano
desde los 65 años, de la AEMPS

733

de 1.390 sustancias del DNMA
(Uruguay) vinculadas

Fuentes y última actualización

FUENTE	QUÉ APORTA	ACTUALIZADA
DDInter	Interacciones fármaco-fármaco con gravedad estructurada, de una base curada.	25/09/2026
AEMPS (España)	Interacciones con mecanismo y manejo escritos, clases de duplicidad terapéutica, criterios en el anciano y nombres en castellano.	25/09/2026
openFDA (EE. UU.)	Interacciones inferidas del texto del prospecto oficial de EE.UU., sólo donde no hay una fuente mejor.	17/09/2026
MED-RT (NLM)	Contraindicaciones y precauciones de cada fármaco frente a patologías.	16/09/2026
RxNorm (NLM)	El identificador (RxCUI) que une a las fuentes entre sí.	25/09/2026
DNMA (MSP, Uruguay)	Las sustancias del registro uruguayo y su grafía local.	16/09/2026
Puente CIE-10	Traduce los códigos CIE-10 que usa el médico a las patologías de MED-RT.	23/09/2026

CÓMO SE INTEGRA

Un servicio, no una pantalla más.

Una sola integración y lo consumen el recetario electrónico, la historia clínica o cualquier otro producto. Y para quien quiera usarlo directo, trae su propia interfaz de consulta, bilingüe castellano/inglés.

Integración con Recetalia

PREPRODUCCIÓN

La API de Recetalia envía los productos del vademécum uruguayo (DNMA) agrupados por producto, y recibe las interacciones y duplicidades de cada uno.

Funciona hoy en el ambiente de preproducción. La visualización en la pantalla del médico está pendiente.

Privacidad por diseño

- **No guarda recetas** ni datos de pacientes: evalúa y responde.
- La base de conocimiento es **de sólo lectura**.
- El motor es propio: no se alquila una base por usuario, y el criterio que carga el equipo clínico queda incorporado.

DEMO PÚBLICA

consilio.medicinainteligente.ai

- **Probar un ejemplo:** carga medicamentos con interacciones conocidas.
- **Ejemplo con paciente:** una paciente de 78 años con enfermedad renal crónica, una alergia y cinco medicamentos.
- **Transparencia:** cifras y fecha de actualización de cada fuente.
- Selector de idioma castellano / inglés.

QUÉ NO EVALÚA TODAVÍA

Lo decimos antes de que lo pregunten

- **Dosis:** sobredosis, infradosis y duración.
- **Incompatibilidad fisicoquímica** entre preparados.
- **Reactividad cruzada en alergias:** hoy se detecta el fármaco exacto declarado.
- **Pediatría.**

En una frase: Consilio cruza los medicamentos que se indican contra fuentes públicas en el momento, avisa con la gravedad más alta que encuentra diciendo de dónde salió, muestra lo que decidió no alertar y por qué, y no afirma nada que no pueda respaldar.

Advertencia. Consilio genera información automáticamente a partir de fuentes públicas. No sustituye el criterio clínico. Que no se encuentre una interacción documentada no significa que no exista. Ante cualquier duda, verificar con el prospecto oficial.